МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЩЁЛКОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ул. Парковая, д.6,
г. Щёлково, Московская область, 141102

Выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного № 26/387-ПН

Ребенок: Бабинова (Мишина)Ника Артемовна (девочка)
Дата рождения: 27.03.26 в 12.40
МСР № 46 1026007421.

Находился на лечении в АФОН ГБУЗ МО ЩПЦ с 27.03.26 по 30.03.26г
Находился на лечении в ОПННД ГБУЗ МО ЩПЦ с 30.03.26 по 01.04.26г

ФИО матери: Мишина Мария Александровна, 29 **лет, 01.12.1996 г.р.**
Адрес регистрации: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 15, к. 3, кв. 10.
Адрес проживания г. Москва, Дохтуровский пер, 6-8
Телефон: 925-701-22-23.

Анамнез: Мать: Группа крови: В (III) Rh-фактор положительный.
Соматический анамнез матери: хронические заболевания отрицает.
Акушерско-гинекологический анамнез: носительство ВПЧ 16 тип
Беременность 1.
Течение данной беременности:
На диспансерном учете состояла с 11-12 недель. ЖК г. Москва.
Течение беременности: 1/3 – б/о; 2/3 – б/о; 3/3 – б/о.
УЗИ-скрининги проведены в декретированные сроки, патологии плода не выявлено.
Бактериологический посев мочи 10.09.2025 г. — роста микрофлоры нет;
Обследование на S. Agalactiae 11.03.2026 г. – не обнаружено.
АТ к T. pallidum 02.02.2026 г. - отрицательные, АТ к ВИЧ 02.02.2026 г. – отрицательные.
HbsAg 02.02.2026 г. - отрицательный. HCV 02.02.2026 г. – отрицательный.
Роды 1 своевременные самопроизвольные в головном предлежании в сроке 38 недель и 5 дней гестации. ПРПО.
1 период – 06 ч. 00 м. 2 период — 01 ч. 40 м. Б/п – 08 ч. 10 м. Околоплодные воды: светлые.

Ребенок: Доношенная девочка.
Масса тела при рождении: **3120 грамм.** Длина **51 см.** Окружность головы **36 см.** Окружность груди **35 см.** Оценка по шкале АПГАР **9/9** баллов

При рождении: спонтанное дыхание с 1 минуты жизни без дыхательных нарушений.
Крик громкий. Кожные покровы розовые. К груди приложен в родильном боксе.
Состояние в динамике: Находился на совместном пребывании с мамой. Крик громкий, двигательная активность достаточная, мышечный тонус физиологический. Рефлексы н/р вызываются. На грудном вскармливании: грудь сосет активно, лактация у мамы устанавливается.
Кожные покровы чистые. Иктеричность 1-4 зон по Крамеру на 3-и сутки жизни.
ТБИ 34-30. Пуповинный остаток под скобой, подсыхает.
По внутренним органам: дыхание пузрильное, проводится симметрично по всем легочным полям, хрипы не выслушиваются.
Тоны сердца ясные, ритмичные, шум не выслушивается. Живот мягкий, печень +1,0 см от реберного края, селезенка не увеличена.
Стул переходный. Мочится свободно.

Обследование:
Общий анализ крови

	RBC, 10^{12}/л.	Hb, г/л.	HCT, %.	WBC, 10^9/л.	Rt %	PLT, 10^9/л.	NE %	LY %	MO %	EO %	BA %	цв
28.03.26	6,8	237	66,5	18,2	-	275	60,2	25,7	9,9	3,7	0,5	1,04

Биохимия крови 30.03.2026 г. в 12:00 билирубин 346-7-339 мкмоль/л.

Диагноз:
Основной: Неонатальная желтуха неуточненная. P 59.9.
Фон: Доношенный новорожденный. Гестационный возраст 38 недель и 5 дней.

Для дальнейшего лечения и обследования ребенок переводится в ОПННД ГБУЗ МО «ЩПЦ» по договоренности заведующего отделением новорожденных Томяк Т. К. и заведующего ОПННД Борисовой А. А.

Состояние на момент перевода: средней тяжести, стабильное. Температура тела 36,7° С. ЧДД 42 в мин., ЧСС 136 в мин.
Масса тела при переводе: 2960 (убыль массы тела составляет 5,1%).

Тяжесть состояния при поступлении обусловлена следующими синдромами:
- Течением неонатальной желтухи.

Динамика состояния в ОПННД: ребенок поступил в ОПННД на 4 с.ж. Режим выхаживания: кровать с подогревом, совместное

пребывание с матерью.
Состояние ребенка при поступлении средней тяжести. Дополнительной дотации кислорода не требует. Эпизодов апно
судорог не отмечалось. Гемодинамика стабильная за весь период наблюдения. В анализах крови маркеров воспаления не
уровень гипербилирубинемии со снижением. В неврологическом статусе повышение уровня церебральной и двигательной
активности. Получал: грудное вскармливание по требованию. Энтеральное питание в динамике расширялось, признаков
непереносимости питания нет. Положительная динамика в наборе веса.

Объективно при выписке: t тела 36,7 °С, ЧД 44, ЧСС 144 в минуту, SpO2 95-98%.
Общее состояние ребенка удовлетворительное. Неврологический статус: в сознании, на осмотр реагирует двигательной
активностью. Череп округлой формы, большой родничок 1,0 *1,0 см, не напряжен, не пульсирует, на уровне костей черепа.
Глазные щели D=S, патологической глазной симптоматики нет. Мышечный тонус дистоничен. Физиологические рефлексы
вызываются. Крик громкий.
Кожные покровы розовые, субиктеричные, влажные, чистые. Тургор мягких тканей удовлетворительный. Подкожно-
жировая клетчатка развита достаточно. Глаза открывает, патологического отделяемого нет. Отеков нет.
Пупочная ранка без признаков воспаления.
Система органов дыхания: грудная клетка цилиндрической формы, симметричная. Спонтанное дыхание есть, ритмичное,
эффективное. Экскурсия грудной клетки достаточная, симметричная. Аускультативно дыхание проводится равномерно,
пуэрильное, хрипы не выслушиваются. На вдохе без участия вспомогательной мускулатуры.
Система органов кровообращения: тоны сердца ясные, ритмичные. АД в пределах нормы. Симптом белого пятна менее 2
секунд. Пульс на периферических артериях удовлетворительных свойств.
Система органов пищеварения: живот мягкий, не вздут, пальпации доступен. Перистальтика кишечника выслушивается.
Отечности передней брюшной стенки: нет. Перитонеальные симптомы отрицательные.
Энтеральное питание: грудное вскармливание по требованию. Объем питания усваивает, не срыгивает. Печень +1,0 см из-
под края реберной дуги, край эластичный. Селезенка не увеличена. Стул самостоятельный. Мочится свободно, регулярно.
НПО сформированы по женскому типу, правильно.

Проведенные обследования:

Группа крови B(III) Rh (+) положит.

Клинический анализ крови:

Дата	Эр ($x10^{12}$ /л)	Нв (г/л)	Нт (%)	Рет %	Тромб ($x10^9$/л)	Лейк ($x10^9$/л)	Миел (%)	п/я (%)	с/я (%)	Лим (%)	Мон (%)	Эоз (%)	НИ (%)
31.03	5.35	182	52.3	-	250	7.6	-	1	40	45	11	3	0.02

Биохимический анализ крови

Дата	**СРБ/ ПКТ** (мг/л)/ (нг/мд)	**Бил общ/ связ** (мкмоль/л)	**Na^+/ K^+/ Cl^-** (ммоль/л)	**Ca общий** (ммоль/л)	**TP/ALB** (г/л)	**AST/ALT** (Е/л)	**Мочев/ Креат.** (ммоль/л)/ (мкмоль/л)	**Глюк** (ммоль/л)
31.03	6.7	193/5	-	-	44.8	31/12	1.5/34	3.7
01.04	0	193/5	-	-	-	42/14	-	-

НСГ 31.03.26: ликворная система не расширена. Структурных изменений не выявлено. Гемодинамические показатели не изменены.
ЭхоКГ 31.03.26: ОАП не определяется. ООО 3 мм. Полости сердца не расширены. Сократительная способность ЛЖ сохранена. Крупные сосуды и клапаны не изменены.
УЗИ ОБП и почек 31.03.26: эхопризнаков патологии не выявлено.

ЭКГ 01.04.26: в работе

Проведенное лечение:
- Охранительный режим
- Профилактика геморрагической болезни новорожденного: Викасол (менадиона бисульфит) 1% - 0.1 мл/кг/сут в/м №1 01.04.26
- Фототерапия

Энтеральное питание: грудное вскармливание по требованию.

Вакцинация против гепатита В проведена 27.03.2026 г. «Комбиотех» 0,5 мл внутримышечно, серия 269-0423, срок годности 04.27 г.
Вакцинация БЦЖ-М проведена 29.03.2026 г. «Медгамал» 0,025 мг внутрикожно, в левое плечо, серия 857, срок годности до 04.2026 г.

Неонатальный скрининг забор крови проведен 28.03.2026 г., ретест 01.04.26 (ТТГ)
Результат исследования от 28.03.26:
GALT, мкг/л: 11.97
Активность биотинидазы неонатальная, нмоль/мл/мин: 149.7
Тиреотропный гормон (ТТГ), мМЕ/л; мкМЕ/мл: **11.3 (норма до 9)**
Иммунореактивный трипсин, нг/мл: 17.43
17-Гидроксипрогестерон, нмоль/л: 20.8

Аудиологический скрининг проведен 29.03.2026 г. Результат исследования: отоакустическая эмиссия: зарегистрирована справа; слева.
Кардиоскрининг проведен, результат отрицательный.

Антропометрические данные:

Возраст	Масса	Рост	Окружность головы	Окружность груди
При рождении	3120	51	36	35
При поступлении	2960 (-160г ПМТ 5.1%)	51	36	35
При выписке	3035 (-85г ПМТ 2.7%)	51	36	35

Ребенок выписывается домой 01.04.26 с диагнозом:
Основной: Неонатальная желтуха неуточненная. P 59.9.
Сопутствующий: ПФК: открытое овальное окно

Рекомендовано:

1. Наблюдение участкового педиатра по месту жительства. При ухудшении состояния ребенка, вялого сосания, отказа от еды вызов участкового педиатра, бригады СМП.
2. Энтеральное питание: грудь матери по требованию. В дальнейшем по согласованию с участковым педиатром. Контроль весовой кривой.
3. Рациональный уход, купание, прогулки.
4. Вакцинация по календарю.
5. Витамин Д3, водный раствор, по 2 капли (1000 МЕ) внутрь ежедневно, длительно
6. Контроль НСГ, УЗИ ОБП и почек, ЭхоКГ в 1 месяц
7. Консультация невролога, хирурга, офтальмолога в 1 месяц
8. Консультация педиатра в отделении динамического наблюдения за детьми раннего возраста (кабинет катамнеза) Щелковского перинатального центра.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (КОПИЯ), МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ОРИГИНАЛ ПЛЮС КОПИЯ, СНИЛС (КОПИЯ), СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (КОПИЯ), ВЫПИСКА ИЗ СТАЦИОНАРА (КОПИЯ). ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПРОИЗВОДИТСЯ С 08:00 - 16:00 ТЕЛ: 8-496-567-39-22

Дата: 01.04.2026

С выписным эпикризом ознакомлена. Всю информацию, интересующую меня, касательно состояния моего ребенка, его диагноза и лечения получила. С рекомендациями ознакомлена. Претензий к ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр», зав.отделением, лечащему врачу и медицинскому персоналу не имею.
Подпись: _____ / _____
ФИО

Для скачивания/открытия электронных медицинских документов рекомендуется использовать только стационарные устройства (компьютер, ноутбук) и российские браузеры (ЯНДЕКС и АТОМ)!!!

Для получения полезной информации о здоровье детей, мерах социальной поддержки в Подмосковье, доступной психологической помощи, дополнительном образовании переходите на сайт - https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/

Врач неонатолог _____ Журавлева И.В.
Зав отделением _____ Борисова А.А.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
телефон 8(496)5668449, добавочный: 3541
электронная почта opnnd2018@yandex.ru